

AS RELAÇÕES ENTRE A PSICOLOGIA E A PSICOFARMACOLOGIA

Ari Bassi do Nascimento*

A Psicofarmacologia é uma abordagem voltada para o estudo de drogas que são ativas no SNC e que influenciam o comportamento de modo geral. As características gerais que são afetadas, às quais nós nos referimos como comportamento são a percepção, o pensamento e a parte afetiva. O conceito de Psicofarmacologia não mais significa o estudo de drogas ou medidas de situações que influenciam a psiquê. Atualmente, Psicofarmacologia refere-se à seleção e uso de drogas que possuem ações específicas no tratamento de distúrbios psicológicos. Seu campo de estudo vai da abordagem experimental sobre os efeitos da drogas, aos níveis bioquímico, neural e comportamental.

Já a Psicofarmacoterapia constitui-se numa prática clínica, a qual evoca e usa conhecimentos obtidos no estudo psicofarmacológico. A primeira trabalha especificamente com a clínica e os seus sujeitos-alvos são primordialmente pessoas. A segunda não: apenas nas fases finais de aprovação de um droga pessoas são arroladas a participar de um protocolo clínico. Nestas fases, pacientes clínicos internos ou não constituem-se em três grupos de sujeitos: aqueles que recebem a droga experimental, os que recebem uma droga controle e aqueles tratados com placebo. Há algumas restrições éticas envolvidas neste tipo de delineamento experimental, as quais quase sempre são discutidas num contexto inflamado.

Aprovada nos últimos ensaios clínicos, a nova droga passa a ser distribuída para clínicas-laboratório, onde é administrada a pacientes sob supervisão terapêutica rigorosa. Essa fase pode durar até 5 anos. Não ocorrendo efeitos colaterais graves que inviabilizem as propriedades terapêuticas da droga ela é aprovada por agências do Ministério da Saúde. Tais agências julgam a conveniência ou não da droga continuar sendo comercializada. Estas práticas, todavia, quase sempre são prejudicadas por interesses econômicos em detrimento

* Depto. de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina - Londrina - Pr. e New Jersey University - U.S.A.

aos da saúde da população-alvo. Isto ocorre muito porque a própria saúde pública não desempenha o seu papel corretamente quando não pune a ausência dessas informações. Por outro lado, os grandes laboratórios impõem seu poder através do estabelecimento de monopólios gigantescos, o que evidentemente gera grupos com poder econômico capaz de gerenciar a comercialização de seus produtos em causa própria. A saúde da população é, nestes casos, muitas vezes negligenciada. Atualmente um terceiro elemento pode ser apontado como uma outra ponta do triplé que dá suporte a esta situação. Este outro elemento constitui-se da completa ignorância do paciente sobre as implicações do medicamento e a crença deste de que a droga é capaz de curá-lo.

Estando a droga no mercado não significa que a ação investigatória da Psicofarmacologia cesse. Pelo contrário, geralmente grandes descobertas sobre os potenciais terapêuticos da droga acontecem nesta fase e muitas vezes são casuísticas. Por outras vezes, após definido a ação segura da droga, ela passa a ser utilizada como uma substância controle para que outras drogas possam ser comparadas, em termos de ação, com ela. Neste caso ela é utilizada em delineamentos experimentais, onde uma ou mais substâncias, com uma ou mais doses, são testadas contra ela. Evidentemente que neste caso uma substância inócua também deve ser utilizada. Estes delineamentos vão de estudos in vitro, in vivo, com animais de laboratório, pacientes hospitalizados, semi-hospitalizados, não-hospitalizados até atingirem a população geral.

Com a liberação da droga para uso sistêmico a Psicofarmacoterapia toma-se a abordagem indicada para trabalhar com a relação droga-paciente. Nesta relação alguns elementos são analisados, tais como o tipo de droga, a duração do uso, a dosagem e elementos-critérios para a continuação ou suspensão do uso.

Não consiste em nenhuma surpresa o fato de que esta abordagem possa ser utilizada levemente às vezes. O uso de fármacos representa a prática terapêutica materializada. Todavia, não é raro que ela concentre conhecimentos que às vezes estão além do domínio de quem a administra. Contudo, a crença do paciente de que a ciência pode encontrar um medicamento para cada doença, reforçada pelo marketing do próprio medicamento, parece eximir o médico da

responsabilidade sobre os efeitos adversos e usos incorretos, indevidos e até desnecessários da droga sobre paciente.

A Psicologia tem criticado a farmacoterapia, alegando que a promoção de soluções rápidas evita definições seguras das relações funcionais que mantêm o comportamento desadaptativo. Os efeitos rápidos da farmacoterapia levam o paciente a um estado de não-responsividade àquelas contingências que até antes da droga estavam controlando o comportamento. Certamente o controle não estava se dando de forma indevida, mas as consequências do comportamento poderiam assim ser classificadas.

Entretanto, com a multidisciplinariedade das áreas do conhecimento qualquer crítica converte-se num ataque incipiente e até, de um ponto de vista teórico, sem contribuições ao conhecimento. Como o número de psicólogos que vai para a clínica tem aumentado ano a ano, uma interação com profissionais ligados à Psiquiatria tem sido inevitável. Longe desta interação ser negativa ela representa um grande avanço na prática terapêutica - com algumas ressalvas, é claro. Estas ressalvas dizem respeito, sem dúvida, do quanto cada abordagem leva ao extremo seus tabus teórico. Em termos pragmáticos esta interação tomou-se efetiva com as descobertas de que a Psicologia e a Farmacoterapia funcionam mais rápido e eficazmente, promovendo com maior brevidade o retorno do indivíduo ao bem-estar. Entretanto, a Farmacoterapia é uma abordagem quase exclusivamente médica, pois não é permitido ao psicólogo receitar, alterar ou suspender um tratamento farmacológico. Mas cabe a este sugerir mudanças neste procedimento se assim ele julgar conveniente. Está mais que claro que este julgamento deve ser feito baseado em conhecimento de causa.

Enquanto não cabe ao psicólogo administrar drogas, a avaliação do uso de tais substâncias constitui-se num problema originalmente da Psicologia. O desenvolvimento de modelos, escalas e uso de conhecimentos sobre os princípios que controlam o comportamento são fundamentais para avaliar as reações dos organismos frente a certas contingências, que neste caso são as drogas. Estas ações da Psicologia, junto com as técnicas de psicoterapia, formam um conjunto de fatores que permitem um relacionamento terapêutico de boa

qualidade. A Psicofarmacologia e a Psicofarmacoterapia não conseguiriam sucesso sem esse conjunto de fatores da Psicologia.